Choque e Sepse · Cartão de Plantão

Para consultar à beira do leito; confira no protocolo do serviço

Reconhecer [SSC] [NICE-F] [AIDPI]

Enchimento > 2 s (AIDPI) ou ≥ 3 s (NICE), extremidades frias, pulso fino, taquicardia (> 160 se < 1 a; > 150 de 1–2 a; > 140 de 2–5 a), sonolência, oligúria. Febre + exantema que não some à pressão com sinais de doença meningocócica: antibiótico já.

Phoenix [PHX]

Sepse: infecção + escore ≥ 2. Choque séptico: + ≥ 1 ponto cardiovascular (vasoativo, lactato ≥ 5, PAM baixa para a idade).

1ª hora [SSC]

Agora	O2, monitor, acesso periférico ou IO
Lactato	Na avaliação inicial
Hemocultura	Antes do antibiótico, sem atrasar
Antibiótico	Choque: até **1 h** · sem choque: até 3 h
Foco	Drenar, retirar cateter infectado

Fluido [SSC] [NICE-L] [AIDPI]

Com UTI	Balanceado 10–20 mL/kg por bolus, até 40–60 mL/kg na 1ª h
Sistema sem UTI	Sem hipotensão: sem bolus · com hipotensão: até 40 mL/kg
Parar	Crepitações, hepatomegalia, choque resolvido
Pré-referência	20 mL/kg SF ou RL; hipoglicemia: SG 10% 5–10 mL/kg
Manutenção	Isotônico; 100/50/20 mL/kg/dia (não neonato); 50–80% se ADH alto

Vasoativo [SSC] [SBP-S]

Perfusão não volta, antes ou depois de 40 mL/kg. Periférico ou IO se preciso. Adrenalina **0,05–0,3 µg/kg/min** (baixo débito) · noradrenalina a partir de **0,05 µg/kg/min** (vasodilatação). Dose alta: considerar vasopressina ou titular mais. Diluição e teto: protocolo do serviço.

Suporte [SSC]

Hidrocortisona só se instável apesar de fluido e droga ou insuficiência adrenal. Intubar: sem etomidato. Após estabilizar: SpO2 88–92%. Bacteremia: infectologia. Descalonar com antibiograma.

Pré-referência [AIDPI]

Ceftriaxona IM **100 mg/kg**, máx. 2 g · penicilina procaína 50.000 UI/kg, máx. 400.000 UI · convulsão: diazepam 0,3–0,5 mg/kg IV ou retal.

Anafilaxia [ANAF]

Adrenalina IM	1 mg/mL: **0,01 mg/kg, máx. 0,3 mg** (adolescente 0,2–0,5 mg), coxa; repetir 5–15 min
Posição	Deitada, pernas elevadas
Volume	5–10 mL/kg em 5 min; 30 mL/kg na 1ª h, por pulso e PA
Broncoespasmo	Salbutamol 1 jato/2 kg, máx. 10
Observar	Leve 6–8 h · grave 24–48 h

Não prescrever

Hidrocortisona de rotina · albumina como 1ª escolha · etomidato · bolus sem reavaliar · anti-histamínico no lugar da adrenalina · esperar acesso central para a droga.